

03

Nivel 3 — Refuerzo intensivo

Empecemos por lo esencial, paso a paso. Cada concepto que domines cuenta — no hace falta saberlo todo de una vez.

NOTA OBTENIDA **1.90 – 3.30**

Cómo estudiar este bloque

Aquí lo que más rinde no es la cantidad de horas, es la constancia diaria y el orden: primero lo básico, después el caso clínico.



Poco y todos los días

15 minutos diarios rinden más que 2 horas una vez por semana. Empieza por lo básico, no por lo difícil.



Primero la definición

Aprende qué es cada cosa (bilirrubina, surfactante, sepsis) antes de

intentar resolver el caso clínico.



Ficha de bolsillo en el turno

Llévala contigo y consúltala cuando surja la duda real. Repetir en contexto ayuda más que memorizar de un tirón.



Pregunta sin miedo

Si algo no quedó claro, pregúntalo en la ronda o a tu jefe de turno. Cada duda resuelta vale más que diez horas sola.

Lo esencial que debes dominar

Empieza aquí. Son las 8 ideas base de todo el temario, explicadas en lenguaje simple.

¿QUÉ ES LA BILIRRUBINA?

Pigmento amarillo que sale al destruirse glóbulos rojos viejos. El **hígado debe procesarla** para poder eliminarla.

¿QUÉ ES EL SURFACTANTE?

Evita que los alvéolos se colapsen al respirar. Lo producen los **neumocitos tipo II** desde la semana 34–36.

FACTORES DE RIESGO • SDR

Prematurez, diabetes materna, cesárea, embarazo múltiple.

HTA materna NO cuenta como factor de riesgo

CURVA DEL SDR

Peor momento: entre las **48 y 72 horas** de vida.

FOTOTERAPIA

La luz transforma la bilirrubina en una forma **soluble en agua** que se elimina sin pasar por el hígado. No "mata" la hemólisis.

COOMBS DIRECTO POSITIVO

Hay anticuerpos atacando los glóbulos rojos del bebé → **hemólisis** (incompatibilidad de grupo).

KERNÍCTERUS

Cuando la bilirrubina indirecta se acumula tanto que **daña el cerebro**. Por eso se trata la ictericia a tiempo.

SEPSIS NEONATAL TARDÍA

Ante signos de alarma: tomar cultivos e **iniciar antibióticos de inmediato**, sin esperar resultados.

Ejercicios prácticos

Empiezan fácil y suben poco a poco. Tómate tu tiempo — no hay apuro.

- 1 Marca V o F: *"La hipertensión materna es un factor de riesgo para que el bebé desarrolle SDR."*
- 2 Completa: el surfactante pulmonar lo producen los neumocitos

tipo ____, y su producción es suficiente alrededor de la semana ____.

- 3 ¿Entre qué horas de vida el SDR suele alcanzar su máxima gravedad?
- 4 ¿Qué significa que el Coombs directo sea positivo en un recién nacido icterico?
- 5 Explica con tus propias palabras qué es la bilirrubina.
- 6 ¿Por qué la fototerapia baja la bilirrubina?
Pista: no es porque "mate" los glóbulos rojos.

----- GIRA LA HOJA PARA VER LAS RESPUESTAS -----

1. Falso. La hipertensión materna acelera la maduración pulmonar fetal — no es factor de riesgo.
2. Tipo II; semana 34–36.
3. Entre las 48 y 72 horas de vida.
4. Que hay anticuerpos maternos pegados a los glóbulos rojos del bebé, causando su destrucción — típico de incompatibilidad ABO o Rh.
5. Es un pigmento amarillo que se produce al destruirse la hemoglobina de glóbulos rojos viejos; debe conjugarse en el hígado para eliminarse por la bilis.
6. Porque la luz transforma la bilirrubina en isómeros solubles en agua (isomerización fotoquímica), que el cuerpo elimina sin necesidad que el hígado la conjugue.

RESPUESTAS • NIVEL 3

- ☐ Bilirrubina: qué es
- ☐ Surfactante: qué es y cuándo
- ☐ Factores de riesgo del SDR
- ☐ Curva temporal del SDR
- ☐ Fototerapia: cómo funciona
- ☐ Coombs positivo: qué significa
- ☐ Kernicterus: por qué se cuida
- ☐ Sepsis tardía: qué se hace primero

Cada casilla marcada es un avance real. Vamos paso a paso — con acompañamiento en el turno y repaso a los 30 días.

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA · NACERSANO IPS